

HISTORIA CLINICA Y EXPLORACION FISICA

Jorge Morano
Juan A. Reichenbach

"Sin la palabra no habría historia y
tampoco habría amor.
Hablamos porque somos, pero somos
porque hablamos..."
(Julio Cortázar)

CONSIDERACIONES GENERALES

La *historia clínica en pediatría* y en medicina general constituye un elemento fundamental para la elaboración del proceso diagnóstico, y su objetivo final el conocimiento del paciente en su contexto de salud y enfermedad. Una evaluación minuciosa, racional y codificada de los síntomas referidos y de los signos evidenciados en su confección, permitirá estructurar un esquema referencial básico de sospecha que orientará al médico en el tortuoso camino hacia el diagnóstico y la terapéutica apropiada, con estrategias eficientes y adecuadas.

El sorprendente apogeo en las últimas décadas de exámenes complementarios sofisticados y de precisiones diagnósticas cibernéticas, a través de complejas tecnologías, parecieron empalidecer la imagen del pediatra clínico general, masificar y computarizar el razonamiento y deshumanizar el concepto y el objetivo final de la relación médico-paciente.

Es en estas circunstancias, en los umbrales del siglo XXI y en el transcurso de la revolución de la tecnología médica, en que todos aquellos que ejercitamos la profesión médica reivindicamos y asumimos el progreso, sin desmedro de lo *artesanal, creativo y humanístico* que nuestra actividad presupone.

Y es en este contexto donde la historia clínica constituye la llave esencial para el diseño de armazones conceptuales, capaces de orientarnos en la interpretación de las manifestaciones del niño enfermo y en el uso racional de la tecnología diagnóstica y terapéutica.

Realizar una historia clínica completa y correcta no es empresa fácil. Dominar la práctica de la anamnesis y el examen físico requiere un conocimiento progresivo que sólo la adecuada formación y la experiencia nos permitirán. Es difícil lograr historias clínicas que discriminen lo esencial de lo accesorio, que procuren la síntesis y la eficiencia en la identificación de la signosintomatología, guía que nos permitirá la estructuración sindromática, la jerarquización de los diagnósticos probables, la pesquisa orientada de los mis-

mos, la confección del diagnóstico transicional y la elaboración de un tratamiento y pronóstico acordes. Además, nuestro archivo de historias clínicas será la base de todo análisis retrospectivo de revisión, sobre cualquier patología que nos interese comparar con la propia experiencia.

La elaboración de la historia clínica significa el primer contacto entre el médico, el paciente y sus padres. La entrevista es de vital importancia y se le debe dedicar todo el tiempo y la atención necesarios. Debe ser realizada en un ambiente apto, confortable, que asegure la intimidad de los datos consignados, que "contenga" la ansiedad paterna y prevenga las interrupciones.

Debe establecerse una verdadera comunicación. En ella los padres del niño refieren información acerca de la dolencia y de sus historias de vida. Obviamente en estas circunstancias, aquéllos se forman una imagen del médico. La actitud general que esté adopte, su postura, el interés que dedique al relato y el apoyo y la comprensión que brinde tienen mucha trascendencia para lograr una buena relación médico-paciente, ejerciendo inevitablemente efectos psicoterapéuticos.

Se ha de escuchar pacientemente lo que los padres expresan, dejándolos expplayarse libremente. Ello evita las distorsiones que suelen producirse en un interrogatorio dirigido, y permite aliviar la tensión familiar. La historia clínica debe ser la compilación ideal que refleje todas las alternativas de la evolución de la enfermedad. Nunca constituirá un fatigoso y rutinario diario descriptivo, tendiendo a la síntesis.

CARACTERISTICAS DE LA HISTORIA CLINICA EN PEDIATRIA

Es por todos conocido que *la historia clínica en pediatría* presenta algunos rasgos que la diferencian de la del adulto.

1. El paciente y las afecciones que lo aquejan son objetos de estudio móviles, condicionados por periodos dinámicos, con alteraciones fisiológicas y orgánicas variables según la edad. La interpretación de un mismo signo o síntoma a diferentes edades es totalmente distinta. Por ejemplo, la ginecomastia en un recién nacido tiene significado muy diferente de la de un niño en edad escolar.
2. En la anamnesis, la recopilación de datos no son propor-

- cionados habitualmente por el paciente, sino generalmente vertidos por sus padres, agregándose un tercer o cuarto sujeto a la relación médico-paciente, lo que no permite que se reproduzcan los síntomas objetivamente, ya que son "teñidos" por la personalidad de su familia; por ejemplo, madres ansiosas o simuladoras.
3. El examen físico tiene acentuadas diferencias con el del adulto, dadas las particularidades funcionales cambiantes del niño a cada edad, su colaboración en el mismo, y el valor relativo de algunas técnicas exploratorias habituales en clínica médica. Por ejemplo, la percusión torácica en lactantes es de escaso valor semiológico.
 4. La interpretación de los hallazgos de la exploración son dispares según la edad del paciente. Así, palpar un bazo a 2 cm del reborde costal es normal en un lactante de 2 meses, pero no lo es en un niño de 7 años.
 5. El mismo criterio dinámico es aplicable en la interpretación de algunos análisis complementarios. Por ejemplo, una hemoglobina de 15 g/dl es tan normal en un recién nacido como una de 11 g/dl en el mismo niño un mes después.

Conceptualmente, el niño no es un "adulto en miniatura", y las variaciones normales y anormales del fenómeno de crecimiento y desarrollo deben ser conocidas para evitar falsas interpretaciones. Esto es fundamental para una eficaz recolección de datos en la anamnesis y en el examen físico.

Por otro lado, es importante señalar que la experiencia en el manejo de la entrevista familiar y en el examen físico, desmitifica el concepto de falta de colaboración y rebeldía del niño examinado. Una actitud serena, dulce, respetuosa y no agresiva, facilita la recolección de datos y la identificación del niño y la familia con el médico, ejerciendo, sin duda, efectos terapéuticos.

Los niños y su familia son jueces inapelables en ese sentido, y la inexperiencia y/o desinterés del médico se evidencian por falta de transferencia y desjerarquización de la autoridad profesional.

NORMAS GENERALES PARA UNA HISTORIA CLÍNICA

La concreción de una correcta historia clínica no es tarea fácil, pues ella sintetiza la capacidad del médico para lograr una síntesis diagnóstica y terapéutica, luego de recoger signos, síntomas y exámenes profusos, no siempre con una razonable lógica. En términos generales, debemos tener siempre presente las siguientes premisas:

1. El objetivo final es el conocimiento integral del enfermo.
2. Debe ser elaborada con orden, siguiendo una sistemática que habitualmente se normatiza en "fichas clínicas".
3. La necesidad de un esquema de orientación no implica que puedan omitirse datos innecesarios para situaciones particulares.
4. Preferentemente, debe ser elaborada íntegramente por el mismo profesional.
5. Tiene que realizarse pacientemente, con interés profesional y humano.
6. Se deben valorar aun los signos y síntomas más sutiles,

sin olvidarse de consignar también los datos negativos útiles para la confección del diagnóstico final.

7. Llegado el momento del diagnóstico, deben priorizarse la síntesis, los elementos positivos constantes, las situaciones de salud y enfermedad habituales para cada comunidad, y el razonamiento y criterio médicos sobre la información desmesurada con escaso análisis.
8. Nunca el diagnóstico debe basarse en exámenes complementarios previos a un análisis concienzudo de la historia clínica de la enfermedad. Por ejemplo, un niño de 7 años con valor de antiestreptolisina O alto, puede no padecer fiebre reumática, pero ese mismo niño con antiestreptolisina O normal, signos de poliartritis migratoria y carditis seguramente está afectado de esa entidad.
9. Todos aquellos que tienen experiencia docente de pre y posgrado, conocen la relación directa entre la calidad de la historia clínica y la capacidad y dedicación profesionales de su autor.

En resumen, la historia clínica es insustituible como método para la adecuada elaboración diagnóstica, y su realización correcta y racional es fundamental para una utilización lógica de los recursos complementarios y terapéuticos. La historia clínica constituye un verdadero documento jurídico, donde se asientan todas las prácticas médicas, tornándose en censor inapelable de la responsabilidad de las conductas y actitudes científicas y humanas.

PARTES DE UNA HISTORIA CLÍNICA

En el gráfico de la fig. 2-1 mostramos esquemáticamente las partes que componen una historia clínica, con un algoritmo que evidencia la cronología lógica del proceso diagnóstico:

1. Anamnesis.
2. Examen físico.
3. Diagnóstico.
4. Exámenes complementarios.
5. Tratamiento.
6. Evolución.
7. Pronóstico.
8. Epicrisis.

Presentamos a continuación un esquema integrado y completo de historia clínica, guía referencial para su confección en pediatría. Analizamos algunos rasgos sobresalientes de cada una de sus partes, para establecer las pautas fundamentales que rigen su elaboración.

ANAMNESIS

El interrogatorio bien orientado constituye una de las partes más valiosas de la historia clínica, y es fundamental en el diagnóstico de aquellas afecciones con escasa traducción clínica o en el comienzo de situaciones de enfermedad. Un buen clínico debe profundizar su observación desde el inicio mismo de la entrevista. Las características de la personalidad de los padres y del niño, sus rasgos físicos, su cuidado en el aseo y la vestimenta, nos brindan una primera aproximación de las características sociales y familiares del paciente.

Los **datos de filiación** orientan globalmente. El **origen étnico** es de importancia, pues es conocida la incidencia variable de ciertas afecciones según él. Así, la displasia de cadera es más frecuente en los pueblos circundantes al Mediterráneo. La intolerancia a la lactosa, en los indios americanos.

El **sexo** tiene también valor. Por ejemplo, las enfermedades del colágeno tienen mayor incidencia en el sexo femenino. Hay multiplicidad de patologías ligadas al mismo.

La **edad** es un factor determinante. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca en el lactante suele ser provocada por cardiopatías congénitas acianóticas, y nunca por la nefritis hipervolémica o la carditis reumática, causas prevalentes en niños de edad escolar.

La **procedencia** es de importancia en el análisis de las patologías endémicas. Por ejemplo, una tumoración quística pulmonar en un niño de ciertas áreas rurales, obliga a

pensar en hidatidosis como primer diagnóstico; una anemia intensa en niños de la región litoral de nuestro país, en la necatoriasis.

Historia familiar. Insistimos en este apartado sobre la importancia del contexto familiar en las situaciones de salud y enfermedad del niño, sea de origen hereditario o ambiental. La historia de las afecciones padecidas por su madre adquieren relevancia. Las enfermedades durante el embarazo, la exposición a fármacos, tóxicos, la historia alimentaria materna, la ocupación habitual, ciertas patologías agudas y crónicas, los hábitos, influyen decisivamente sobre el producto de la gestación.

Testimonio de ello son los productos emergentes de madres que han padecido lúes en el último trimestre del embarazo, las características de los hijos de madres alcohólicas (síndrome alcohólico fetal) y los hijos de madres

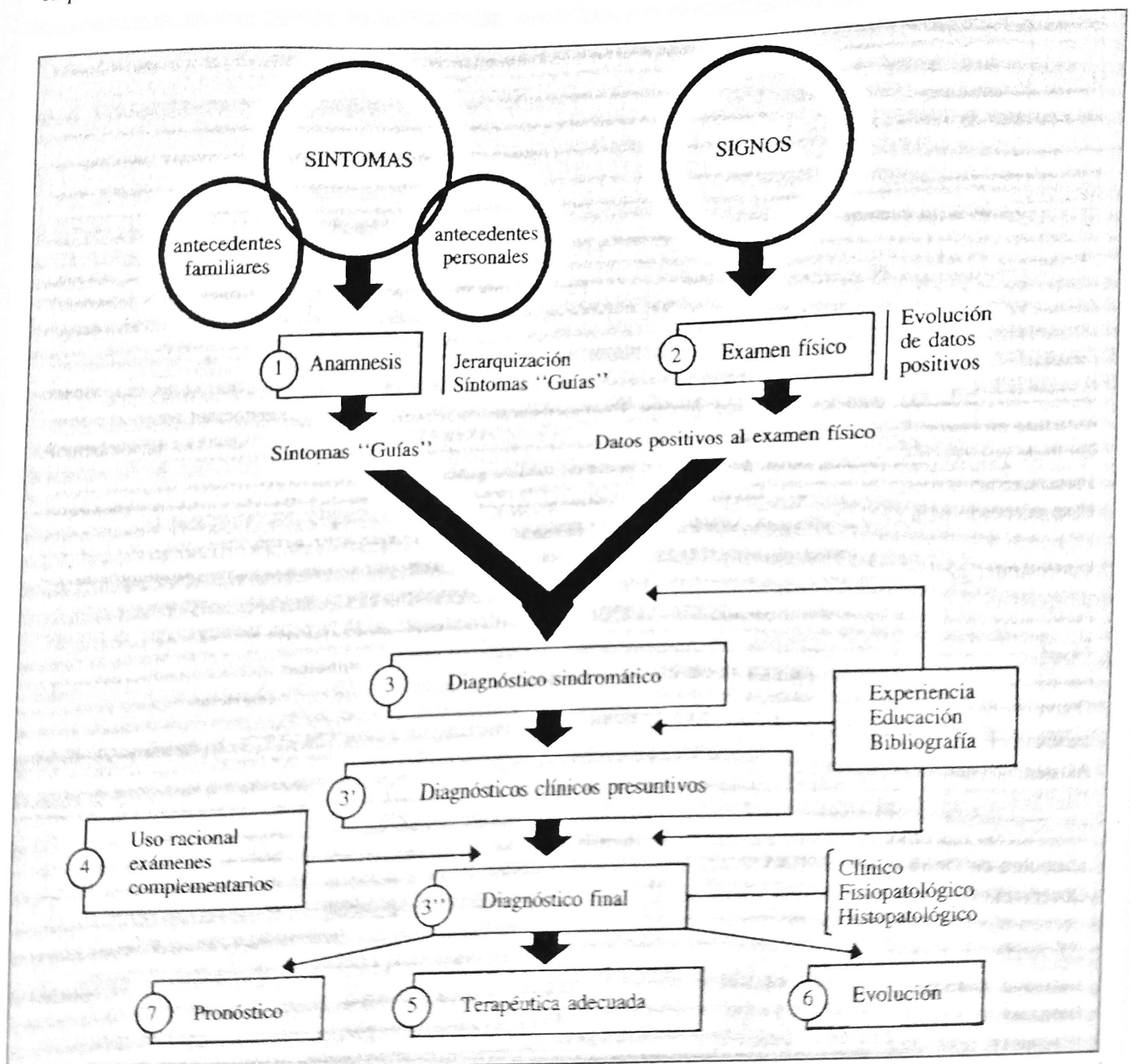


Figura 2-1.

fumadoras, diabéticas o hipertensas no controladas. Conocemos la influencia que ejerce sobre la salud del hijo la prevalencia en el medio familiar de la tuberculosis,

parasitosis y enfermedades de transmisión sexual. La confección de un árbol genealógico completo permitirá pesquisar afecciones hereditarias.

Esquema referencial para la confección de una historia clínica pediátrica

Historia Clínica N°

ANAMNESIS

Datos de filiación:

Apellido y nombre: Sexo: Edad: Procedencia:
 Lugar de nacimiento:
 Sala: Servicio: Fecha:
 Apellido y nombre del responsable: Parentesco:
 Dirección: Obra Social:

Enfermedad actual:

Motivo de consulta:

Antecedentes de enfermedad actual:

Antecedentes personales:

Gestación e historia neonatal

- Embarazo: N° Duración: Fecha última menstruación: Controlado:
 Salud materna: Medicación recibida: Rx:
 Vacunas: Aumento de peso:

- Parto:

Espontáneo, inducido, eutócico, distócico, fórceps. Cesárea (causa):
 Atendido en hogar. Sanatorio. Hospital, por:
 Recibido por obstetra; partera; otros; neonatólogo; pediatra; médico general. Otros
 Presentación: Recién nacido pretérmino. Recién nacido de término. Recién nacido postérmino.
 Peso adecuado para edad gestacional. Grande para edad gestacional. Pequeño para edad gestacional

Antecedentes perinatólogicos

Peso: Talla: Perímetro cefálico:
 Apgar 1 minuto: 5 minutos:
 Llanto: Asfixia: Cianosis: Ictericia:
 Convulsiones: Hemorragias: Infecciones:
 Incubadora: Oxígeno: Presión positiva continua:
 Asistencia ventilatoria mecánica:
 Canalización umbilical: Medicación:
 Eliminación meconio: Diuresis: Caída cordón:
 Maniobra de Ortolani:
 Observaciones:

Nutrición

Lactancia materna: Lactancia materna y biberón:
 Biberón: Preparación:
 Vitaminas, tipo, edad, dosis:

Historia clínica y exploración física

Incorporación de semisólidos. Tipo y cronología:
 Incorporación de sólidos:
 Comentarios:
 Vómitos: Diarrea: Constipación: Regurgitación: Pica:
 Dieta actual. Tipo y cantidad:

Crecimiento y desarrollo

Gráficos de peso, talla y perímetro cefálico.
 (Véanse gráficos).

Maduración psicomotora

Sonrisa social: Cabeza erecta: Sentado con apoyo: Caminó con
 Sin apoyo: Gateo: Parado:
 apoyo: sin apoyo:
 Palabras: Gorgojeo: Monosílabos:
 Mamá/Papá: Tres palabras: Frases:
 Preensión palmar: Pinza cubital: Pinza digital:
 Control esfínter vesical: Control esfínter rectal:
 Escolaridad:
 Lecto-escritura:
 Juegos: Actitud lúdica:
 Deportes:
 Lectura. TV. Música:
 Trastornos de aprendizaje:
 Colecho: Cohabitación: Cólicos 3er. mes:
 Angustia anaclítica:
 Sueño: Pesadillas: Sonambulismo:
 Otros trastornos funcionales:
 Actitud social:

Inmunizaciones

B.C.G.: D.P.T.: Sabin: Anti H. Influenzae:
 Antisarampionosa: dTa (doble adultos): Otras:

Historia de enfermedades anteriores

Edad: Evolución: Complicaciones:

Hospitalizaciones:

Antecedentes familiares

- Padre	Edad:	Ocupación:	Nacionalidad:
	Escolaridad:	Hábitos:	
	Impresión:		
	Enfermedades padecidas:		
- Madre	Edad:	Ocupación:	Nacionalidad:
	Escolaridad:	Hábitos:	
	Impresión:		
	Enfermedades padecidas:		

- Cabeza y cara

Cráneo: Forma: Tamaño: Suturas: Fontanelas:
 Craneotabes: Colecciones: Heridas:
 Palpación: Percusión:
 Cuero cabelludo:
 Cara: Expresión mímica: Forma: Asimetrías: Tics:
 Ojos: Enoftalmos (cuantificación): Exoftalmos:
 Ptosis: Epicantus: Fotofobia: Lagrimeo:
 Motilidad ocular: Nistagmus. Parálisis. Estrabismo: convergente, divergente:
 Características conjuntivas: Secreciones. Epifora:
 Córnea: Opacidades: Reflejo corneal:
 Pupilas: Reflejos: Simetría:
 Alteraciones iris y pupila:
 Agudeza visual: Visión de los colores:
 Campimetría: Fondo de ojo:

- Oídos:

Pruebas elementales de audición:
 Forma, posición y anomalías de pabellones auriculares:
 Otoscopia: Conducto auditivo: Tímpanos: Mastoides:

- Nariz:

Forma. Tamaño. Situación:
 Aleteo nasal: Permeabilidad:
 Secreciones purulentas, hemorragias: Cuerpos extraños:
 Transiluminación senos paranasales:

- Boca. Faringe. Laringe.

Aliento: Respiración bucal: Labios:
 Coloración: Malformaciones:
 Encías: Dentición: número, cronología de aparición, forma, tamaño, color:
 Caries: Maloclusión: Traumatismos:
 Mucosa bucal: color, humedad, lesiones, sialorrea:
 Forma y función palatinas: Lengua, características:
 Amígdalas: Uvula: Pilares: Secreción rinofaríngea:
 Llanto. Voz. Estridor. Disfonía:

- Cuello:

Tamaño: Forma: Posición: Motilidad: Adenomegalias:
 Tumoraciones: Ubicación: Edemas:
 Pulso arterial y venoso: Tiroides: Tráquea:

- Tórax:

Inspección: forma, tamaño, retracciones, deformaciones. Circulación colateral:
 Diámetro anteroposterior: Rosario costal:

- Aparato circulatorio:**- Inspección:****- Precordio:****- Palpación:****- Auscultación:****- Soplos:**

Palidez: Cianosis: Perfüción periférica: Tensión arterial:
 Asimetrías: Abombamientos: Retracciones:
 Latidos: Características:
 Pulsos periféricos: Prémios:
 Choque de punta: Frecuencia: Intensidad:
 Ruidos cardíacos: Variaciones fisiológicas:
 Ritmo: Localización: Intensidad: Propagación:
 Ruidos normales y agregados: Sistólico: Diastólico: Variaciones:
 Localización: Relación con ruidos:
 Frémios: Prote pericárdico:
 Ritmo galope:

- Aparato respiratorio:

Inspección: Características de la respiración:
 Tipo: Ritmo: Profundidad: Frecuencia:
 Tiraje: Tos: Expectoración: Disnea:
 Palpación: Frémios:
 Percusión de ambos hemitórax y columna: Roncus:
 Auscultación: murmullo vesicular: Estertores:
 Sibilancias: Soplos:
 Evaluación clínica de la suficiencia respiratoria:

- Abdomen:

Inspección: Simetría: Forma: Movimientos respiratorios:
 Distensión: Asas visibles:
 Circulación colateral: Hernias: Peristaltismo:
 Palpación: Sensibilidad: Tensión: Contractura y defensa muscular:
 Puntos dolorosos:
 Hígado y bazo: Tamaño: Forma: Consistencia:
 Tumoraciones: Características y tamaño:
 Percusión: Ascitis:
 Auscultación: Ruidos hidroaéreos (normales, de lucha, ausentes):
 Examen lumbar:

- Aparato urinario. Genitales:

Visualizar la emisión de orina: Voluntaria: Involuntaria:
 Características del chorro miccional: Ritmo miccional:
 Peloteo y palpación renal: Puntos ureterales:
 Puñopercusión: Percusión hipogástrica:
 Examen de genitales: Grados de Tanner:
 Maduración sexual: Malformaciones:
 Descenso testicular: Hernias: Hidrocele:

Ano y recto:

Implantación anal:
 Hemorroides: Fístulas: Fisuras:
 Materia fecal: características de las deposiciones (frecuencia, consistencia, aspecto, enterorragia, melena):
 Pujos y tenesmo: Encopresis: Tacto rectal:

Extremidades:

Forma: Longitud: Malformaciones:
 Relación SS/SI:
 Articulaciones: Motilidad activa y pasiva: Dolor:
 Tumefacción: Temperatura: Edema:
 Derrame articular: Signo de Ortolani:
 Columna vertebral: Deformaciones: Tumoraciones: Dolor:
 Percusión: Examen de la motilidad:

Músculos:

Desarrollo de masas musculares:
 Tono: Excitabilidad: Fuerza: Contracturas:
 Hipertrofias: Atrofias:

Sistema nervioso:

- Evaluación esquemática de la maduración psicomotriz:
 Paresias y parálisis: Reflejos motores osteotendinosos:
 patelar, aquiliano, bicipital, tricipital, cubital, mentoniano, supraorbitario:
 Cutaneoabdominales: Cremasteriano:
 Babinski: Signos meníngeos:
 Pares craneanos: Fondo de ojo:
 Taxia: Romberg: Metría: Decúbito: Marcha:
 Exploración de nervios periféricos:
 Exploración del lenguaje:
 Exploración de la conciencia:

1. Diagnóstico sindromático.
2. Diagnóstico presuntivo.
3. Diagnóstico fisiopatológico.
4. Plan de estudio.
5. Tratamiento.
6. Pronóstico.
7. Evolución.

La historia de salud de sus hermanos, así como su alimentación permitirá inferir déficits nutricionales del paciente analizado.

Historias reiteradas y recurrentes de procesos gastrointestinales agudos en los hermanos o de infecciones respiratorias con persistencia del círculo infección-desnutrición, permitirá detectar a un paciente en situación de alto riesgo social. La anamnesis familiar que indique el antecedente de hermanos muertos tempranamente por enfermedad

respiratoria inexplicada, en un paciente sospechoso, orientará hacia el diagnóstico de mucoviscidosis, de transmisión autosómica recesiva. Un recién nacido de bajo peso, con historia materna de abortos espontáneos, deberá obligarnos a descartar la posibilidad de infecciones congénitas.

Historia personal. A este ítem lo podríamos dividir en:
 a) Antecedentes personales no relacionados aparentemente con la enfermedad actual.

- b) Antecedentes de la enfermedad actual.
- c) Desarrollo de la enfermedad actual.

Obviamente, la historia comienza con el *embarazo*. El estado de salud materna, la medicación recibida, la deseabilidad o no del embarazo, los controles realizados, son todos eventos sutiles que aportan datos valiosos. Por ejemplo, en algunas comunidades de escasos recursos económicos se prefiere la descendencia masculina sobre la femenina, explicando la alta incidencia de niñas desnutridas y abandonadas.

Las características del *parto* y del *nacimiento* "sellarán", en pocas horas, el futuro del nuevo ser. Nada es tan trascendente para la calidad de vida como el nacimiento. Pocos minutos bastan para decidir la integración de un ser vivo potencialmente apto para desarrollarse en la comunidad.

Así, cuando analizamos, por ejemplo, a un niño con secuelas motoras, déficits intelectual y sensorial, será obligatorio un prolijo análisis de los *periodos pre, intra y posnatal inmediato*.

El puntaje de Apgar es demostrativo en este sentido. Un recién nacido con un puntaje bajo al minuto del nacimiento evidencia un alto índice de mortalidad neonatal, y aquellos con Apgar bajo a los 5 minutos, presentarán gran posibilidad de morbilidad futura.

Otros aspectos neonatales son también importantes para la evaluación de signos y síntomas de presentación posterior. Por ejemplo, en un niño con clínica de hipertensión portal, deberá descartarse el antecedente de cateterización de vena umbilical y el uso de soluciones hiperosmolares en el nacimiento inmediato.

Una anemia acentuada del lactante podría ser explicada por enfermedad hemolítica del recién nacido secundaria a incompatibilidad fetomaterna.

El niño es un ser dinámico y cambiante. Su historia es la de la mielinización de su sistema nervioso central, la del desarrollo de sus bronquios, la del perfeccionamiento de sus funciones psíquicas, motoras y sensoriales, y la del crecimiento y desarrollo pondoestatural.

La energía común de todos estos procesos surge de su alimentación, de allí que la *historia alimentaria* sea esencial en el análisis de los procesos de salud y enfermedad. La concreción o no de la lactancia materna con sus implicancias fisiológicas y psíquicas, el detalle de las fórmulas utilizadas, el momento y el método de incorporación de sólidos, las intolerancias y alergias referidas, la armonía y calidad de los nutrientes utilizados, son de real trascendencia.

El efecto profiláctico de la leche de madre en las diarreas bacterianas y afecciones respiratorias, ha motivado que su promoción se destaque en los planes de educación sanitaria. Existen verdaderas patologías del destete como el *Kwashiorkor*, en los países subdesarrollados.

En la enfermedad celiaca, la incorporación del gluten precede algunos meses al comienzo de la signosintomatología. La exclusión de los lácteos elimina las manifestaciones gastrointestinales en pacientes con déficit de la actividad de lactasa.

Un buen registro de las *inmunizaciones* constituye un excelente indicador de los cuidados de la familia hacia el niño, y desde el punto de vista de la salud pública, del nivel sanitario de la población. Las vacunas previenen infecciones epidémicas y evitan formas graves de enfermedades frecuen-

tes. Por ejemplo, es raro observar casos de meningitis tuberculosa en niños que han recibido B.C.G.

La valoración del *crecimiento y desarrollo* es fundamental para evaluar un organismo dinámico. Así, globalmente, un lactante que logra la pinza digital y la posición erecta al año de edad, manifiesta un excelente desarrollo neurológico. Un lactante de 3 meses con suficiente aporte alimentario, y retardo o detención del aumento ponderal, puede responder a alguna afección subclínica (cardiopatía congénita, infección urinaria, malabsorción, etc.). Preocuparía el aumento inarmónico del perímetro cefálico con respecto a la longitud y al peso, evidenciando la posibilidad de una hidrocefalia evolutiva.

El análisis completo de alteraciones sutiles del crecimiento y desarrollo, orientará precozmente en el diagnóstico de ciertas afecciones graves (síndrome de Marfan, hipotiroidismo, etc.).

Historia de patologías anteriores. Real jerarquía tiene, en la evaluación de la enfermedad actual, todo dato relacionado con situaciones anteriores. Por ejemplo, cuando analizamos la historia de un lactante de 9 meses con insuficiencia cardíaca por cardiopatía congénita acianótica, es habitual en la historia anterior la presencia de episodios de bronquitis recurrentes, insuficiente progreso ponderal y soplo cardíaco neonatal.

Un adolescente que consulta por enfermedad pulmonar obstructiva, es probable que tenga el antecedente de enfermedad bronquiolítica en la lactancia. Debe elaborarse minuciosamente la historia previa, detallando las características de cada proceso, tratamientos, exámenes realizados, con su secuencia cronológica.

Historia de la enfermedad actual. Constituye el capítulo de mayor importancia en la anamnesis y el motivo de preocupación que condiciona la consulta familiar. Por ello, en la entrevista debe ser prioritariamente enfocada.

El *motivo de consulta* debe resumir en pocas palabras los síntomas guiones fundamentales; por ejemplo: ictericia, dificultad respiratoria, cefalea, anorexia, fiebre, etc.

La historia de la enfermedad actual debe ser minuciosa, cronológica, precisa, jerarquizando los síntomas referidos por los padres o el niño. Deben explicitarse las manifestaciones esenciales diferenciándolas de las accesorias, los cambios experimentados con terapias instituidas y la repercusión general sobre el paciente.

Han de analizarse la calidad y las peculiaridades de cada síntoma.

Por ejemplo, en un niño con dolor abdominal recurrente, se valorará la duración, intensidad, localización, propagación, síntomas asociados, factores desencadenantes, cronología de los episodios, personalidad del niño y la familia. Indudablemente, debe primar el *criterio unicista* y tratar de agrupar los síntomas y signos en su apariencia confusos y anárquicos, en unidades conceptuales. Así, un niño con fiebre, adenomegalias y esplenomegalia nos hará pensar en mononucleosis infecciosa, y no en una enfermedad infecciosa, asociada con enfermedad metabólica con atesoramiento esplénico. No hay "signos patognomónicos", hay signos que son más frecuentes en ciertas afecciones. Nada es excluyente en pediatría.

EXAMEN FISICO

El examen físico debe efectuarse en un ambiente confortable, adecuado, sin interferencias ni interrupciones. El paciente debe estar desnudo, tranquilo, conociendo previamente, sin engaños, las maniobras que el médico desarrollará. Debe tratarse cordialmente al paciente y sus familiares, haciéndolos "cómplices" de nuestro interés por sus dolencias.

No han de realizarse métodos agresivos poco útiles en su eficiencia diagnóstica (por ejemplo: tacto rectal en situaciones que no lo requieran). Sugerimos una "ficha modelo", que pretende ser sólo una guía para el examen físico. Aportaremos de cada apartado, sólo algunos aspectos que pudieran ser de utilidad para la elaboración y análisis de cada situación.

Generalidades e inspección general. La observación y la evaluación global del niño son gestos semiológicos fundamentales en clínica pediátrica, que aportan frecuentemente datos más valiosos que otras técnicas de exploración. Es trascendente "ubicar" al niño en el "polo salud-enfermedad", detallar el momento en que comienza a presentar actitudes diferentes de aquellas que desarrolla habitualmente (alimentación, sueño, actividad lúdica, escolaridad). El tiempo de latencia de estas alteraciones marcará el comienzo larvado o agudo de la afección. Por ejemplo, el cambio de carácter antecede en semanas a la signología florida de la meningoencefalitis tuberculosa. La tos irritativa a medianoche puede preceder largamente a una crisis asmática. Sólo horas de evolución anteceden a un shock meningocócico.

Cuando evaluamos a un niño enfermo, debemos discriminar en qué medida se afectan las funciones vitales (volemia en una epistaxis cataclísmica, suficiencia respiratoria en una bronquiolitis grave, suficiencia renal en una nefritis aguda, etc.).

Preferentemente, el paciente debe ser examinado en condiciones basales, para evitar situaciones que induzcan a error. Por ejemplo, la hipertermia puede producir la falsa apreciación de un síndrome meníngeo, mala perfusión periférica, polipnea, etc. Signos aislados sin otros datos positivos en el examen físico pueden orientar puntualmente. Por ejemplo, palidez aguda sin hemorragias evidentes en un niño anoréxico, asténico y triste, de 6 años de edad, hace sospechar leucemia.

Un niño en edad escolar que ingresa deshidratado, en coma, con polipnea y poliuria, sugiere cetoacidosis diabética. La evaluación del aspecto general y una orientación rápida con pocos elementos, constituyen las situaciones que sólo la experiencia clínica provee.

La *piel* es el "espejo del organismo". Del análisis de su textura pueden inferirse el tiempo y la intensidad de una desnutrición. De su turgencia, humedad y elasticidad puede calcularse el porcentaje de deshidratación de un niño con diarrea aguda.

El tinte icterico orientará en un recién nacido hacia la necesidad de luminoterapia. Una intensa rubicundez nos hará pensar en poliglobulia.

La presencia de edemas nos indicará que el paciente tiene más de un 5% de líquido por encima de su peso habitual. La presencia de cianosis nos obligará a descartar cardiopatía congénita o metahemoglobinemia.

El cabello opaco, resquebrajado, escaso, de fácil caída nos orientará hacia la desnutrición crónica, tanto primaria como secundaria a malabsorción.

Las *uñas* en vidrio de reloj son fiel documento de afecciones productoras de hipoxia crónica (cardiopatías, enfermedad fibroquística del páncreas). Alopecias difusas en niños con serios problemas de conducta, orientarán hacia la tricotilomanía. Alopecias circunscriptas, hacia afecciones micóticas (tiñas).

Normalmente, hasta los 8 a 10 años de edad, el *sistema linfático* presenta un aumento fisiológico relativo.

La presencia de *ganglios linfáticos* palpables en regiones habituales, de alrededor de 1 cm de diámetro, es un hecho frecuente y fisiológico. Las adenomegalias generalizadas hacen sospechar la interurrencia de una afección sistémica. En cambio, una adenomegalia localizada en la región cervical, con signos de flogosis y dolor, nos orienta a pensar en una etiología bacteriana. La presencia de adenopatías suboccipitales, esplenomegalia y exantema, sugiere rubéola.

La observación de la *cabeza y cara*, y la armonía o no de sus rasgos, nos orientarán hacia el diagnóstico de diversos síndromes genéticos. Sutiles hallazgos (características del pelo, disposición de hendiduras palpebrales, implantación auricular, forma de la nariz, características dentales, etc.), nos harán pensar en algunas enfermedades por alteraciones cromosómicas. En un niño sano, su expresión mímica es un elemento objetivo de valor (facies afilada en la peritonitis, disneica en enfermedad respiratoria, vultuosa en hipertermia, cianótica en cardiopatías congénitas).

La observación minuciosa de los *ojos* permitirá el diagnóstico de estrabismo incipiente, debiéndose recordar que éste, intermitente y fugaz, puede ser fisiológico hasta los 6 meses. Leucocoria (generalmente manifestación de cataratas), nistagmus, epifora (habitual en la dacriocistitis y en la estenosis u obstrucción transitoria del conducto lagrimal).

La evaluación adecuada de la *dentición* es útil. Así, su retardo más allá de los 15 meses constituye un hecho anormal y podría sugerir, entre otras cosas, raquitismo. La ausencia o anormalidad de las piezas dentarias es habitual en varias enfermedades congénitas (displasia ectodérmica, entre ellas).

El *cuello* es localización frecuente de tumoraciones. Las ubicadas en la línea media, harán pensar en quiste tirogloso; en la región laterocervical en adenomegalias; si es unilateral, preauricular y sub-ángulo-maxilar, consistente y dolorosa con la masticación, en una parotiditis crónica.

La inspección del *tórax* es fundamental en pediatría. El aumento de su diámetro anteroposterior, en un lactante disneico, orientará a pensar en una enfermedad obstructiva con compromiso de la pequeña vía aérea (bronquiolitis aguda). La palpación de la articulación condrocostal engrosada (rosario costal), es sinónimo de déficit de vitamina D (raquitismo). La observación de tiraje intercostal evidencia utilización de los músculos accesorios de la respiración.

Un lactante con disminución localizada del murmullo vesicular en un hemitórax y fiebre, nos sugerirá condensación pulmonar bacteriana; un niño en edad escolar con espiración prolongada y sibilancias, crisis asmática; un prematuro con dificultad respiratoria grave y abolición del murmullo vesicular, enfermedad de membrana hialina. La percusión torácica tiene poca validez en niños pequeños.

El *abdomen* distendido, doloroso en la palpación superficial, lo que se acrecienta con la descompresión, con predominio en fosa iliaca derecha, obliga a descartar la apendicitis aguda. La palpación de la "oliva pilórica" confirma la sospecha de estenosis hipertrófica de píloro en un recién nacido de 20 a 30 días, con vómitos y falta de aumento ponderal. Un tacto rectal con materia fecal teñida en sangre, en "jarabe de grosellas", es altamente indicativo de invaginación intestinal en un lactante mayor, con cuadro de oclusión intestinal.

Es un hecho habitual la palpación del polo inferior del *bazo* en los primeros años de la vida, especialmente en el lactante. Algo similar ocurre con el *hígado*. Una evaluación acabada de su tamaño real, de su consistencia y de sus peculiaridades permitirá no incurrir en errores semiológicos. Con las características de liso, blando e indoloro, se palpa normalmente entre 2 y 3 cm del reborde costal en el recién nacido; 1 a 2 cm a los 2 años; hasta 1 cm en el 50% de los niños a los 5 años y en el 10% de los de 10 años de edad.

Excepto en el recién nacido, es muy difícil acceder a la palpación *renal*. La percusión renal está sujeta a variables de interpretación inconsistentes. Es fácil conocer las características de la *vejiga* por palpación y percusión radiada en la zona hipogástrica.

Gran valor tiene la observación de la *micción*, las características del chorro y de la orina emitida, así como la alteración del ritmo y volumen miccional normal. Del simple acto de observar un recién nacido con dificultad para iniciar la micción, puede surgir el diagnóstico temprano de válvulas de *uretra* posterior, actuando oportunamente en una afección que por lo común se diagnostica tardíamente, con consecuencias nefastas para el paciente. La simple comprobación de una poliuria nos pone en la pista de la diabetes, evitando con su diagnóstico oportuno los episodios de cetoacidosis que la caracterizan. La observación de la cronología de una hematuria macroscópica ayuda al diagnóstico de cistitis hemorrágica.

Debe jerarquizarse, en la consulta ambulatoria, el registro de la *tensión arterial*, que permitirá detectar niños con hipertensión esencial o de causa orgánica (habitualmente nefrógena), realizando la profilaxis y terapéutica adecuadas.

La relación entre los diferentes segmentos corporales y la talla total tiene validez en algunas patologías. Por ejemplo, un niño con talla alta, con predominancia del segmento inferior (miembros inferiores) sobre el superior, es característico del síndrome de Marfan.

La talla baja con igualdad en la relación entre segmento superior e inferior, es peculiar de los pacientes con déficit de STH.

En cambio, una talla baja con predominio del segmento superior sobre el inferior, es habitual en los hipotiroidismos (enanos de piernas cortas).

Es de primordial importancia también la exploración de la *maduración psicomotriz* del niño. El examen neurológico minucioso en el recién nacido es vital para detectar déficits sutiles. En el niño de edad escolar, la dificultad en la lectoescritura puede manifestarse por trastornos del aprendizaje.

La exploración de la conciencia, según la escala de Glasgow, es fundamental en la evolución de algunas patologías (traumatismos, intoxicaciones, shock).

Para terminar, queremos destacar muy especialmente que un apropiado examen clínico nunca deberá excluir, en todas las edades, una somera estimación de las funciones visual y auditiva. Se deberá efectuar siempre un adecuado examen otoscópico, ya que son muy frecuentes las otitis serosas o mucossecretorias, condicionantes de hipoacusias de conducción, responsables de trastornos de conducta y aprendizaje. El otoscopio, probablemente más que cualquier otro instrumento, simboliza la experiencia del pediatra y su dedicación para hallar el origen de la enfermedad en su pequeño paciente.

DIAGNOSTICO

Luego de una exhaustiva anamnesis y prolijo examen físico, habremos recogido una serie de datos que será preciso analizar, buscando las interrelaciones que nos orienten a la elaboración de la propuesta diagnóstica. Efectuando un adecuado proceso de síntesis con correcta jerarquización de los síntomas "guías" y de los datos positivos del examen físico, lograremos plantear un *diagnóstico sindromático*, que puede abarcar etiologías, fisiopatologías e histopatologías variadas.

A modo de ejemplo, presentamos el siguiente paciente: lactante de sexo masculino, de 6 meses de edad, con dificultad respiratoria, rechazo alimentario e imposibilidad en la conciliación del sueño. Se encuentra subfebril y con rinitis desde hace 72 horas. En el examen físico presenta dificultad respiratoria moderada, discreto tiraje universal, aleteo nasal, disminución global del murmullo vesicular y espiración prolongada. Examen cardiovascular normal. Frecuencia cardíaca: 140 por minuto. Frecuencia respiratoria: 68 por minuto.

El *síntoma "guía"* es la dificultad respiratoria. Los *signos "guiones"* son los resultantes de la dificultad ventilatoria (taquipnea, disminución global del murmullo vesicular, dificultad en la espiración, tiraje universal). El *diagnóstico* es: "síndrome bronquiolítico".

El *diagnóstico clínico presuntivo* es: síndrome bronquiolítico por "bronquiolitis enfermedad". No hay elementos de la anamnesis y del examen físico que hagan sospechar insuficiencia cardíaca, tuberculosis, bronquitis bacteriana, neumonitis por hidrocarburos, coqueluche, intoxicación salicilica, entre otras entidades que podrían manifestarse como síndrome bronquiolítico. Es en este momento de elaboración diagnóstica, cuando el clínico debe recurrir, con criterio racional, a los *análisis complementarios*, con el concepto de efectuarlos sólo en beneficio del diagnóstico final y/o en función de la terapéutica adecuada.

En el paciente relatado, la radiografía de tórax mostrará signos inequívocos de hiperinsuflación pulmonar que ayudarán al diagnóstico presuntivo, aunque la confirmación final estaría dada por el aislamiento del *virus sincitial respiratorio*, el de mayor frecuencia como agente causal de bronquiolitis.

El análisis de los gases en sangre mostrará hipercapnia con discreta hipoxia, y más raramente acidosis respiratoria, con lo que podemos realizar el *diagnóstico fisiopatológico* de insuficiencia ventilatoria obstructiva.

Este diagnóstico nos ayuda a comprender la *patología*

de esta afección: alteración inflamatoria de la pequeña vía aérea sin compromiso parenquimatoso.

En esta etapa del análisis, con un diagnóstico certero, el médico está en condiciones de proponer la *terapéutica* adecuada, prever la *evolución* más probable, hacer la profilaxis de las *complicaciones* y elaborar el *pronóstico* a largo plazo. Por ejemplo, es conocida la instalación de atelectasias como complicación inmediata frecuente en la evolución de la bronquiolitis.

En lo que respecta al pronóstico a largo plazo, se ha demostrado una mayor incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en adultos que han padecido bronquiolitis en el primer año de vida.

Es indudable la trascendencia de la anamnesis y el examen físico para lograr diagnósticos correctos. Los exámenes complementarios, aun los más sofisticados, siguen siendo recursos excelentes para el diagnóstico, siempre que se utilicen luego de un análisis criterioso de cada situación clínica en particular.

Con la ecografía abdominal, por ejemplo, se puede diagnosticar un bazo vesical, pero lo razonable es hacerlo con la palpación y percusión del hipogastrio. Debe erradicarse el concepto de "*exámenes de rutina*", debiéndose concebir al paciente y su enfermedad en un contexto de desequilibrio biopsicosocial, y no como un mero objeto, sujeto a una batería cibernética y agresiva de exámenes sin una finalidad preconcebida clara.

Mucho es lo que se puede discutir acerca del valor de los *análisis complementarios*. Para ello podríamos imaginar algunas categorías. Los *rutinarios*, masificados en la asistencia diaria y generalmente poco interpretados, con un índice de confiabilidad pobre.

El recuento de glóbulos blancos, como signo de infección bacteriana es sólo una ayuda en la interpretación de un cuadro clínico poco claro. Así, una leucocitosis con neutrofilia, *per se*, se encuentra en situaciones tan variables como: en el recién nacido normal, en la crisis asmática, en la infección bacteriana y en cualquier situación de estrés. La ausencia de leucocitosis no descarta infección apendicular o aun sepsis.

Un análisis completo de orina normal no descarta la infección urinaria, y una orina con bacteriuria, hemáties aislados, cilindruria y proteinuria, puede ser producida por fiebre motivada por una infección viral banal. La antiestreptolisina O elevada puede ser provocada por una reciente vacunación antitetánica, y no es frecuente una fiebre reumática aguda con ASO normal. Una PPD, que vira 10 mm sin B.C.G. previa confirma primoinfección tuberculosa, pero una PPD negativa no descarta tuberculosis miliar.

Hay exámenes más *específicos*, que confirman diagnósticos presuntivos. Un urocultivo positivo aclara el diagnóstico de infección urinaria, pero su negatividad en un cuadro clínico sospechoso no la descarta. Nadie niega la utilidad de

los cultivos bacterianos, la serología y los *screenings* metabólicos. Lo que se discute es la oportunidad racional y seleccionada de su indicación. Para ello son necesarias la información permanente y la utilización de algoritmos de estudio, que se basan en los conocimientos estadísticos y científicos de cada síndrome y afección en particular.

Por ejemplo, a ningún clínico criterioso se le ocurriría iniciar el estudio de un tumor abdominal con un "colon por enema", contando con la ecografía que los ubica y los clasifica, permitiendo hasta tomas biopsicas y diagnósticos histológicos precoces. En la actualidad, la tomografía axial computada constituye un excelente recurso diagnóstico, especialmente para ciertas topografías (por ejemplo, las alteraciones del sistema nervioso central), que obviamente ha desplazado a otras prácticas agresivas (angiografía cerebral).

Sintetizando, el manejo adecuado de los tiempos, la selección de los recursos diagnósticos, la recolección fiel de los síntomas y signos, el análisis operativo y global de cada enfermo en particular, la actualización científica permanente, la intuición "artesanal" del médico experimentado, y el objetivo de curar, forman el contexto de una profesión esencialmente humanística.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alden ER y Dow J: Guías para la revisión de historias clínicas. *Pediatrics in Review*, 12: 131, 1991.
- Behrman RE, Kliegman R, Arvin A: Nelson. *Tratado de Pediatría*. 15ª ed. Ed. Interamericana, México. 1998.
- Evaluación de historias clínicas en un hospital pediátrico. *Rev. Hosp. Niños*, 25: 251, 1983.
- Flores M: Responsabilidad médica e historia clínica *Rev. Hosp. Niños* 26: 58, 1984.
- Galdó A, Cruz M: *Exploración clínica en pediatría*. Barcelona, Masson SA.; 1995.
- Green M: *Pediatric diagnosis*. 3a ed. Philadelphia, W.B. Saunders MG, 3-21, 1980.
- Illingworth RS: *Basic developmental Screening*. Oxford Blackwell Scientific, 172-229, 1987.
- Illingworth RS: *Development of the infant and young child, normal and abnormal*. 7a ed. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1979.
- Illingworth RS: A suggested child health clinic form. *Arch. Dis. Child*. 54: 626-634, 1979.
- Kempe H, Silver HK, O'Brien DO: *Diagnóstico y tratamiento pediátricos*, 7a ed. México D.F., El Manual Moderno, 1996.
- Macri C, Plaza A, Rocco R: Errores frecuentes en la confección de la historia clínica y sugerencias para subsanarlos. *Rev. Hosp. Niños*, 24: 157, 1982.
- Nazarian L F: Revisión de las historias clínicas del pediatra. *Pediatrics in Review*, 12: 133-135, 1991.
- Oski FA: *Pediatría, principios y prácticas*. 1ra. ed. Buenos Aires, Edit. Médica Panamericana, 1993.
- Weed LL: Medical records that guide and teach. *New Engl. J. Med*. 278: 593, 1968.
- Wood B P: What has become of the physical examination? *American Journal of Diseases of Children*, 144: 963-964, 1990.
- Zuckerman B: Family history: a special opportunity for psychosocial intervention. *Pediatrics*, 87: 740-741, 1991.